

KC桌面——外资精译

美国制药与生物科技

美国制药与生物科技：ASCO现场医生视角的洞察

周一，我们在ASCO 2026上与顶尖肺癌临床医生及研究者Fred Hirsch博士共同举办了一场KOL早餐会。会议涵盖了周末公布的最重要数据，Hirsch博士就一系列早期和晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的新兴疗法及试验结果提供了其临床观点。

关键议题包括：selpercatinib在RET阳性疾病中的LIBRETTO-432辅助治疗数据、ivonescimab在鳞状NSCLC中的HARMONi-6试验结果、lorlatinib更新的CROWN数据、下一代ALK和KRAS抑制剂、TROP2靶向ADC，以及围绕分子检测、治疗时长和某些肺癌亚型逐渐被视为慢性病等更广泛的主题。

- HARMONi-6令人鼓舞，但关键未解问题是，一项仅在中国进行的研究能否推广至全球人群。在鳞状NSCLC中，OS风险比为0.66，且VEGF相关出血风险可控，这好于预期；但Hirsch博士提醒，患者筛选细节仅为描述性，年龄上限为75岁，且中国人群可能无法完全对应西方临床实践。他明确表示，不会仅凭风险比来决定处方——该药物要在临床中赢得一席之地，需要满足两个条件：获批，以及HARMONi-3在全球人群中得出一致结果；H3的OS数据预计在2026年下半年公布。
- RET辅助治疗数据为早期靶向治疗设立了新基准。LIBRETTO-432显示，selpercatinib（LLY）在RET+辅助治疗NSCLC中取得了0.17的风险比——这是该领域最显著的有效性信号之一——但关键的实施挑战在于检测，因为约70%的RET+患者是从不吸烟者，不符合标准筛查标准。
- Lorlatinib的门槛仍然极高，但Nuvalent在lorlatinib不适用及耐药患者中有一条可信的路径。CROWN研究在7年随访时仍未达到中位PFS——治疗时长可能令人印象深刻；Nuvalent的第四代ALK抑制剂在lorlatinib复发患者中显示出约26%的缓解率，并解决了那些有神经毒性或合并症患者的真实未满足需求。
- KRAS是NSCLC一线治疗的下一个主要战场。Divarasib在KRAS G12C一线治疗中的数据被描述为可能改变临床实践，而更广泛的RAS领域——包括Revolution Medicines的G12D和pan-RAS(ON)抑制剂——进展速度超出许多人预期。
- Sac-TMT正成为NSCLC中最令人信服的TROP2药物，但全人群与生物标志物驱动的争论仍未解决。Hirsch博士认为数据令人信服，但在缺乏伴随生物标志物策略方面，他在理念上仍感矛盾——这种张力可能影响该药物最终相对于Datroway的定位。

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停评级 NUVL, SMMT, BNTX, RVMD, INCY, NBIX, JAZZ 的盈利预测为报告每股收益；NUVL, SMMT, BNTX, RVMD, INCY, NBIX, JAZZ 的估值为报告市盈率；来源：彭博，Bernstein预测与分析。

投资启示

美国生物制药：我们给予LLY和GILD跑赢大盘评级；给予ABBV, AMGN, BMY, MRK, MRNA, PFE与大市同步评级。

美国生物科技：我们给予NUVL和NBIX跑赢大盘评级；给予BNTX, RVMD, JAZZ和INCY与大市同步评级；给予SMMT跑输大盘评级。

详情

RET+早期疾病 - LIBRETTO-432 (Selpercatinib)

针对RET阳性患者进入早期疾病的LIBRETTO-432研究被强调为周末最令人信服的数据集之一，延续了EGFR突变疾病中ADAURA和ALK阳性疾病中ALINA开创的模式。Selpercatinib是一种具有良好中枢神经系统穿透性的选择性RET抑制剂，在随机辅助治疗中取得了惊人的0.17风险比，尽管无事件生存期（EFS）终点尚未达到，但EFS曲线已明显分离——临床视为明确阳性。值得注意的是，总生存期（OS）仍是患者最关心的终点，该研究尚无OS数据可用，尽管EFS是该场景下合理且被接受的主要终点。关键未解问题依然存在：合适的治疗时长（目前最长3年，ctDNA监测是未来的潜在工具，但早期患者脱落的循环DNA少于晚期患者，使检测不那么直接）；缺乏中枢神经系统保护数据；以及最关键的是，如何检测这些患者，因为约70%的RET+患者是从不吸烟者，不符合当前肺癌筛查资格标准，估计约30%在1B-3A期确诊（尽管Hirsch博士指出，鉴于其在纽约的行医实践，这个数字可能偏高）。分子特征描述在临床实践中仍不完整——即使在资源充足的环境中，组织样本要求仍是一个障碍，而早期疾病中的液体活检不如晚期疾病可靠。其他几项针对早期分子亚型（包括ROS和HER2异常肿瘤）的研究正在进行中。

中国RET抑制剂 (Lunbotinib)

一种中国RET抑制剂也展示了强劲数据，具有良好的脑穿透性，可能足以支持在中国获批。然而，按照FDA标准做法，在寻求美国监管路径之前，需要在全世界西方人群中重复验证。

HARMONi-6 - Ivonescimab在鳞状NSCLC中的应用

康方生物（由Rebecca Liang覆盖）仅在中国进行的HARMONi-6研究评估了ivonescimab（一种PD-1xVEGF双特异性抗体）联合化疗对比替雷利珠单抗联合化疗治疗鳞状NSCLC，取得了0.66的OS风险比，结果与PD-L1状态无关，且毒性可控。历史上与VEGF抑制相关的鳞状肿瘤出血风险（因其中央、空洞性解剖结构）在H6中并非显著问题，但有人对潜在的患者筛选效应提出质疑——年龄上限为75岁，且入组标准被描述为仅为描述性而非分析性定义。Hirsch博士强调，他不会将处方决策锚定于特定的风险比阈值，而FDA基于阳性全球HARMONi-3 III期研究的标签将是他在评估真实世界效用之前的先决条件；患者层面的因素，包括年龄、肿瘤位置、合并症、出血/坏死风险和体能状态，都至关重要。他指出，其鳞状NSCLC患者中略多于一半年龄超过65岁——这是一个需要个体化评估VEGF抑制风险收益比的庞大群体——尽管这一比例正逐渐年轻化。HARMONi-3，即SMMT的全球III期试验，在最近的中期分析中未达到统计学显著的PFS。最终PFS分析和OS中期分析预计将在今年下半年进行。

PD-L1分层与新兴治疗检测方法

Hirsch博士指出，如今对于PD-L1高表达患者，他通常给予免疫单药治疗而非化疗联合方案，这种做法仅适用于少数病例——主要保留给较年轻患者、肿瘤负荷较高者或有症状的患者，因为对他们而言，增加化疗的获益足以证明其毒性是值得的。一种新兴的蛋白质组学液体活检检测方法（Prophet，由Oncohost开发）正在研发中，并在回顾性研究中显示出识别哪些患者需要额外化疗的潜力——但尚未在临床上得到确立或获批。

Sacituzumab Tirumotecan (Sac-TMT) 与 TROP2 在非小细胞肺癌中的应用

在ASCO上公布的Sac-TMT（一种抗TROP2 ADC）数据被认为比竞争性TROP2药物更具说服力，尤其是在非鳞状非小细胞肺癌中帕博利珠单抗联合或不联合Sac-TMT的治疗背景下。Hirsch博士表示，鉴于他作为生物标志物研究者的背景，他对这种“全人群”策略在理念上存在一些矛盾，但他承认这些数据令人信服。ADC相对于化疗的毒性仍然难以一概而论——患者反应差异很大——并且临床试验通常排除体能状态较差的患者，限制了向真实世界的推广。

CROWN研究更新——洛拉替尼与下一代ALK抑制剂 (Nuvalent)

洛拉替尼的CROWN研究更新被描述为设定了非常高的标准，在7年随访中位无进展生存期仍未达到——这与Hirsch博士2000年抵达美国时ALK阳性患者6-7个月的中位生存期形成鲜明对比。Nuvalent的第四代ALK抑制剂因对

洛拉替尼耐药肿瘤具有活性（在洛拉替尼复发患者中约26%的缓解率）而值得关注，并可能开辟一个有意义的细分市场，因为部分患者因神经毒性或合并症不适合使用洛拉替尼；Hirsch博士并不常见到体重增加或神经系统问题，部分原因是

在他的临床实践中，ALK阳性患者每年仅约5-6例。他指出，尽管洛拉替尼（第三代ALK TKI）数据更优，但围绕阿来替尼（第二代ALK TKI）的临床惯性花了数年才克服——这意味着Nuvalent可能面临类似的采用挑战——不过他相信持续的数据积累最终将推动其在洛拉替尼不合格患者中的应用。治疗持续时间仍是一个悬而未决的问题，没有明确答案；ctDNA和液体活检监测是未来希望使用的工具，但就目前而言，如果耐受性可接受，患者通常不愿停止治疗——Hirsch博士以自己二十年前作为癌症幸存者的经历来说明这一点，当时他收到了各种各样的建议，但最终选择了继续治疗。

ROS1、外显子20插入突变与KRAS G12C

ROS1在Hirsch博士的临床实践中过于罕见，无法给出有意义的评论。外显子20插入突变仍然主要是一个亚洲患者人群的故事，基于舒沃替尼的联合疗法值得未来关注（由John Heymach报告）。KRAS G12C在一线治疗中的数据（divarasib）被描述为可能改变临床实践，因为KRAS的患病率高于ROS1或外显子20插入突变。更广泛的KRAS/RAS领域——包括来自Revolution Medicines的G12D和泛RAS(ON)抑制剂——正在快速发展，早期信号令人鼓舞，但仍需完整数据。

PD-1xVEGF联合新型机制（整合素 β -6 / 辉瑞）

PD-1xVEGF与整合素 β -6（可能由辉瑞主导）的潜在组合被认为是一种有趣的机制组合，但被指出缺乏生物标志物驱动的开发策略——Hirsch博士认为这是一个重大缺失。在评估其临床效用之前，需要更多数据。

NCCN指南与临床实践理念

Hirsch博士表示，鉴于数据产生的速度，他相信NCCN指南将继续滚动更新，通常以月为单位，而非天或年——这是NCCN模式的功能，该模式能迅速召集专家组，并且比许多其他指南框架更高效地对证据进行分级。关于更广泛的临床决策问题，他强调治疗决策绝不仅仅由风险比驱动——患者层面的因素、耐受性、期望值和合并症都影响着共同决策过程，医生应该治疗的是患者，而非数据点。他将这一理念部分归因于自己二十年前作为癌症幸存者的经历，当时他的生存曲线看起来并不乐观，他收到了各种各样的建议；他妻子关于“中位生存期是给统计学家看的，不是给个体患者看的”的观察，概括了他如今如何与自己的患者进行对话。展望更远的未来，他指出，对于某些分子亚型，肺癌正接近一种慢性病模式——患者确诊后现在可能存活7-10年——这使得生存者计划成为一个日益紧迫的关注领域，而肺癌学界尚未完全优先考虑这一点；这些计划需要同等程度地解决身体、心理、家庭和经济方面的影响。

I. 必要披露

Bernstein是SG（SG）与联博有限公司（AB）合资企业的一部分。除非特别注明，就这些披露而言，提及Bernstein的“关联方”均指SG和AB及其各自的关联方。

估值方法

本研究出版物涵盖六家或更多公司。有关估值方法和其他公司披露：

请访问：<https://bernstein-autonomous.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action>。

或者，您也可以致函：Director of Compliance, Bernstein Institutional Services LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167。

风险

本研究出版物涵盖六家或更多公司。有关风险和其他公司披露：

请访问：<https://bernstein-autonomous.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action>。

或者，您也可以致函：Director of Compliance, Bernstein Institutional Services LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167。

公众号：KC桌面